

105.09.02



“優生” 滋心 膜衣錠

Perzin F.C. Tablets "Yu Sheng"

衛署藥製字第001941號

“優生” 維諾心 糖衣錠75公絲(待匹力達)

Parotin S.C. Tablets 75mg "Y.S."

衛署藥製字第028592號 **G.M.P G-0300**

【成分名(中文名)】 Dipyridamole (二吡待摩)

【劑型、含量】

滋心膜衣錠 (Perzin F.C. Tablets): 每錠含Dipyridamole 25mg
維諾心糖衣錠 (Parotin S.C. Tablets): 每錠含Dipyridamole 75mg

【臨床藥理】

活體外及活體內的研究顯示本藥之主成分dipyridamole能抑制紅血球、血小板及內皮細胞對腺核苷(adenosine)的攝取，在治療濃度(0.5-2mcg/ml)時，最大的抑制效果可達80%，其作用程度與劑量相關。此種作用使得局部作用於血小板A₂接受體(platelet A₂-receptor)之腺核苷(adenosine)的濃度增加，刺激血小板之腺核苷環狀酶(platelet adenylyl cyclase)，導致血小板環狀腺嘌呤核苷二磷酸(platelet cAMP)的濃度增加。因此可抑制血小板致活因子(PAF)、膠原(collagen)、腺嘌呤核苷二磷酸(ADP)等所引起的血小板凝集作用(platelet aggregation)。血小板凝集之減少能降低血小板的消耗，使之回復到正常的濃度。此外，腺核苷(adenosine)具有血管擴張作用，此亦為dipyridamole產生血管擴張作用的機制之一。約在1小時後達到最高血漿濃度，靜脈注射後主要的半衰期約為40分鐘，靜脈注射後可觀察到較長的排除半衰期約為13小時。Dipyridamole與血清蛋白的結合率約97%至99%。Dipyridamole在肝臟代謝，其代謝物(大約有95%)主要由膽汁從糞便排出。

【適應症】

對於慢性狹心症之治療可能有效。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。
宜於空腹(飯前一小時或飯後兩小時)伴一大杯(240ml)水服用，吸收較快。
為減少胃腸刺激，可於飯中或飯後服用。
建議之用法用量如下，除非醫師另有處方：
慢性狹心症患者一次25mg，一日三次。
一般兒童劑量：目前尚未建立。

【注意事項】

1. 本藥對孕婦及授乳婦之安全性尚未確立，但應就其使用上之危險與效益加以考慮。FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：B
2. 有傾向於低血壓的病人，本藥之使用應小心。
3. 本藥無法減輕急性心絞痛發作之痛楚，但有助於發作之防止及減少。
4. 本藥用於心絞痛之預防上，達到充分療效可能需時2-3個月。
5. 高達800mg之每日劑量曾被用於心臟瓣膜(Cardiac valvular)及腎臟外科手術後減少血小板之凝集。
6. 在使用口服抗凝血劑時，每日服用本藥高達400mg，不會影響到Prothrombin之活性及出血時間。
7. 投用本藥時，如從躺臥或坐姿起立時應加小心。
8. 用藥過多會發生週邊血管舒張，低血壓病患小心使用。
9. 本藥並不能阻止急性狹心症發作。
10. Dipyridamole的特性使其作用類似血管擴張劑。對患者有嚴重之冠狀動脈疾病患者應小心使用，包括不穩定性心絞痛病人、最近發生心肌梗塞者、左心

室流出阻塞(left ventricular outflow obstruction)或血行力學的情況不穩定者(如代償機能衰敗造成之心衰竭)。已規則口服dipyridamole的病患，不應再接受靜脈注射之dipyridamole。

11. 本藥使用於重症肌無力患者時，如改變dipyridamole之劑量，可能需要調整治療。
12. 曾報告在少數病例發現膽結石內含有不同程度之未結合(unconjugated)的dipyridamole(最高者佔結石之乾燥重量的70%)。這些都是年老的病人，而且有上行性細膽管炎(ascending cholangitis)，且都已接受口服dipyridamole治療多年。無證據顯示dipyridamole是引發這些病人結石的因素。其可能的機制是細菌使膽汁內已結合之dipyridamole(conjugated dipyridamole)進行去葡萄糖醛酸化作用(deglucuronidation)，而使得膽結石內出現dipyridamole。

【相互作用】

1. Heparin與本藥併用時，會增加出血之危險；與Xanthin derivation(如theophylline、caffeine衍生物)合用時，其血管擴張作用可能會被減弱。
2. Dipyridamole會增加血漿中腺核苷(adenosine)的濃度及加強adenosine對心臟的作用。二者併用時，應考慮調整adenosine的劑量。
3. 當dipyridamole和抗凝血劑及acetylsalicylic acid併用時，應小心觀察是否出現這些藥物所敘述之藥物不耐性(intolerance)及危險性(risks)。於acetylsalicylic acid之劑量再併用dipyridamole，不會增加出血的危險。Dipyridamole與warfarin併用時，出血之頻率或嚴重性不會比單獨使用warfarin時嚴重。
4. Dipyridamole可能會增強降血壓藥物的降壓作用。Dipyridamole可能會對抗膽鹼酯酶抑制劑(cholinesterase inhibitors)的抗膽鹼酯酶作用(anticholinesterase effect)，故使得重症肌無力症惡化。

【副作用】

劑量增加時，如有下列副作用，如：眩暈、頭昏眼花、昏厥、面紅、頭痛、噁心、嘔吐、皮膚發疹、胃絞痛或虛弱等持續時，應予醫療照顧。
在治療劑量下，本藥副作用通常是暫時且輕微。曾觀察到的副作用包括嘔吐、腹瀉及下列症狀如眩暈、噁心、頭痛、肌肉痛。長期以dipyridamole治療時，這些副作用通常會消失。
由於其血管擴張作用，dipyridamole可能會造成低血壓、熱潮紅(hot flushes)及心跳加速。在極少數病例曾觀察到冠狀動脈心臟病的症狀惡化。
極少數之病例發生手術中或手術後出血增加的情形。
血小板減少症的個案曾被報告與使用dipyridamole有關。
曾觀察到dipyridamole混雜於膽結石中。

【賦形劑】

Perzin F.C. Tab.

Microcrystalline cellulose, calcium Phosphate Dibasic, Povidone, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Sepifilm

Parotin S.C. Tab. 75 mg

Lactose, Starch, Microcrystalline Cellulose (Avicel 101), Silicon Dioxide (AD-101), Sodium Starch Glycolate (Primojel), Polyvinyl Pyrrolidone K30 (PVPK-30), Magnesium Stearate, Sucrose, Gelatin, New Coccin (Food Red No.6), Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5), Hypromellose 615, Castor oil, Dibasic Calcium Phosphate (Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate)

【儲藏】室溫25℃以下貯存。

【代號、包裝】

藥品名稱	代號	包裝
滋心膜衣錠 (Perzin F.C. Tab.)	SU-0100	12-1,000粒/塑膠瓶裝、鋁箔盒裝
維諾心糖衣錠75公絲 (Parotin S.C. Tab. 75mg)	PT-0176	6-1,000粒/塑膠瓶裝、鋁箔盒裝



優生製藥廠股份有限公司
台中市南屯區工業區21路14號

MM 201602

127x250mm